

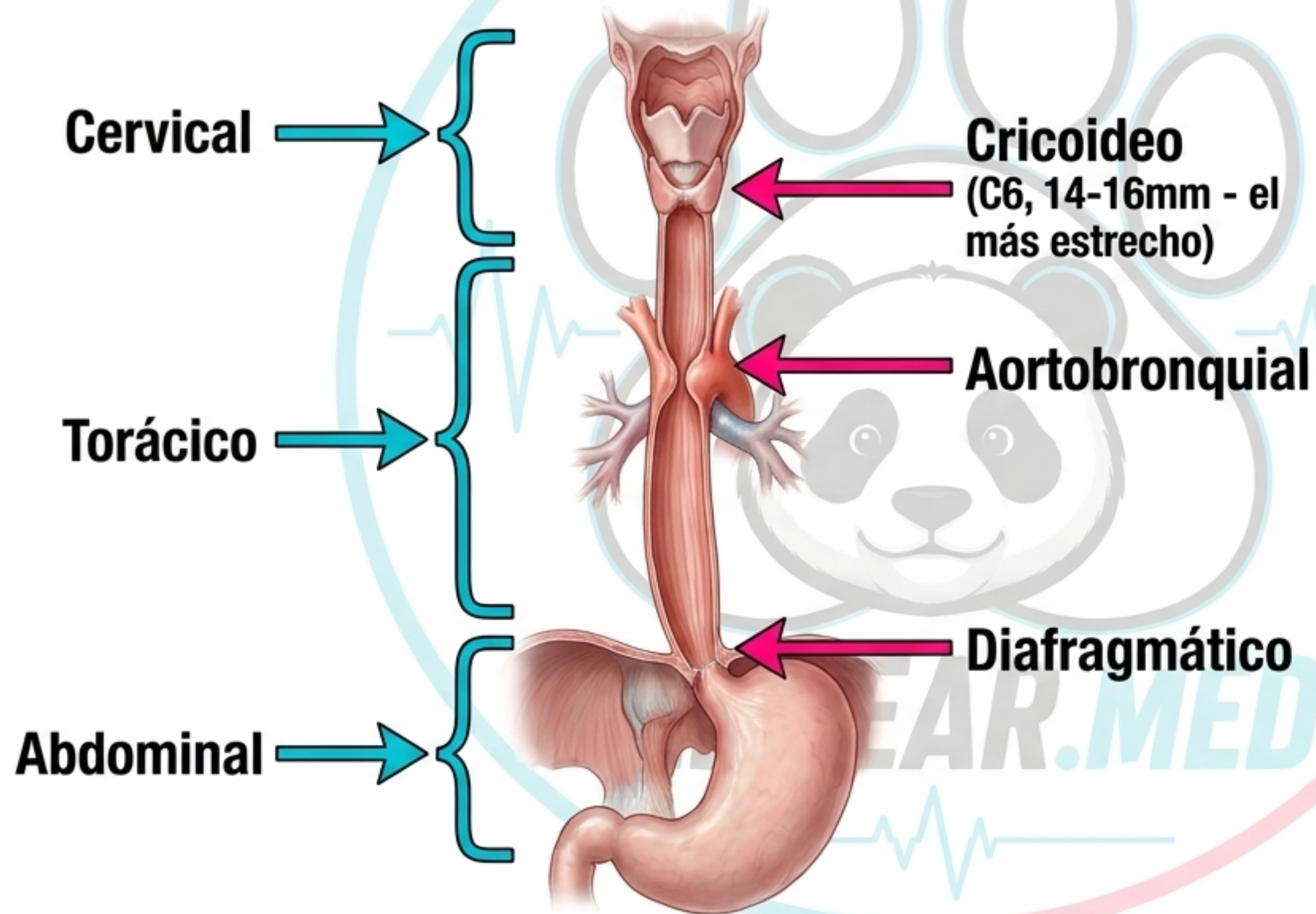


Patología Quirúrgica Benigna y Maligna del Esófago

Guía de Estudio Detallada - Protocolos Quirúrgicos y Anatómicos

Proyecto Oficial BADBEAR.MED

Anatomía Quirúrgica: El Mapa del Esófago



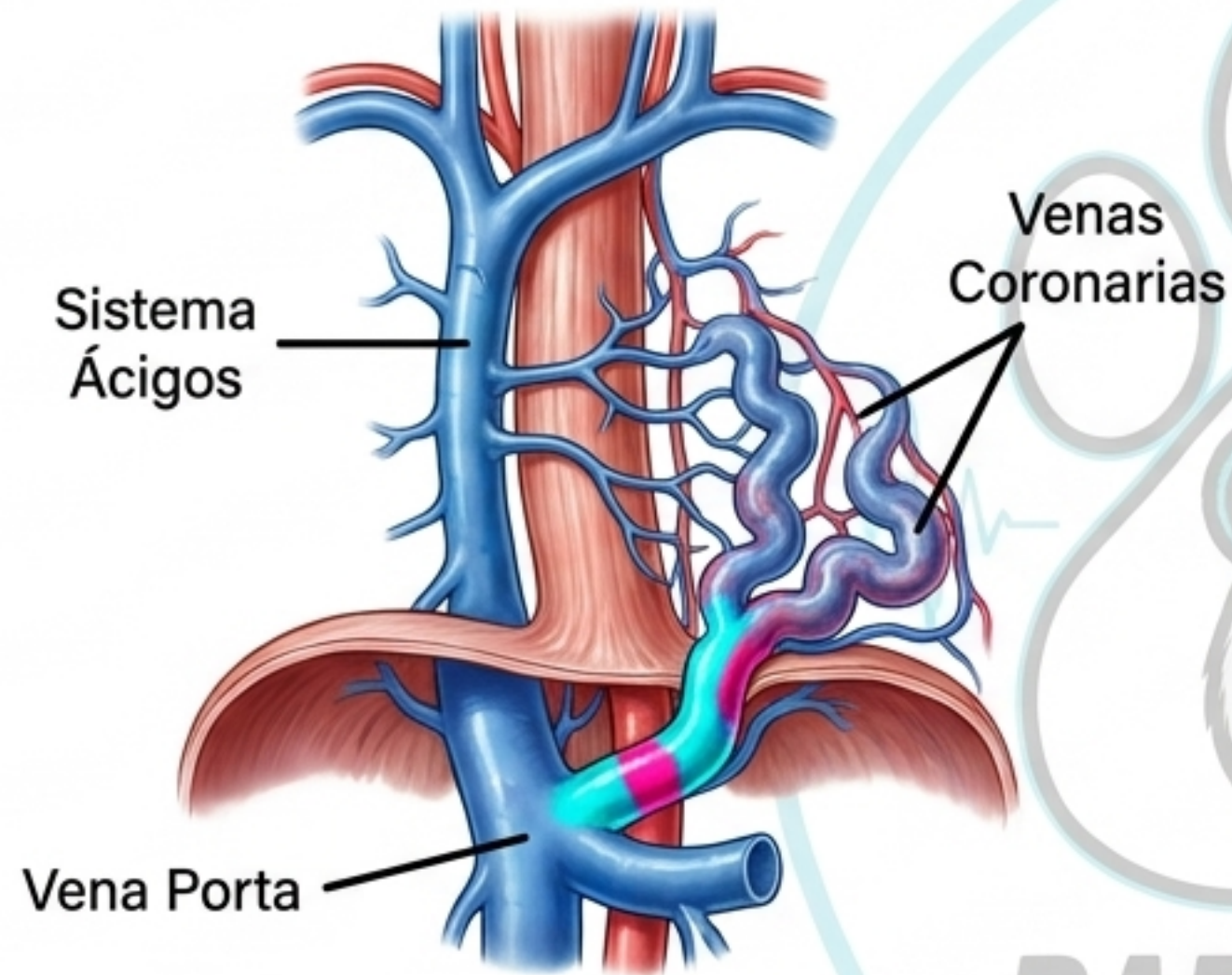
Mucosa: Capa más resistente. Crucial para anclar suturas en anastomosis.

Fibras Musculares: Circulares internas, longitudinales externas.

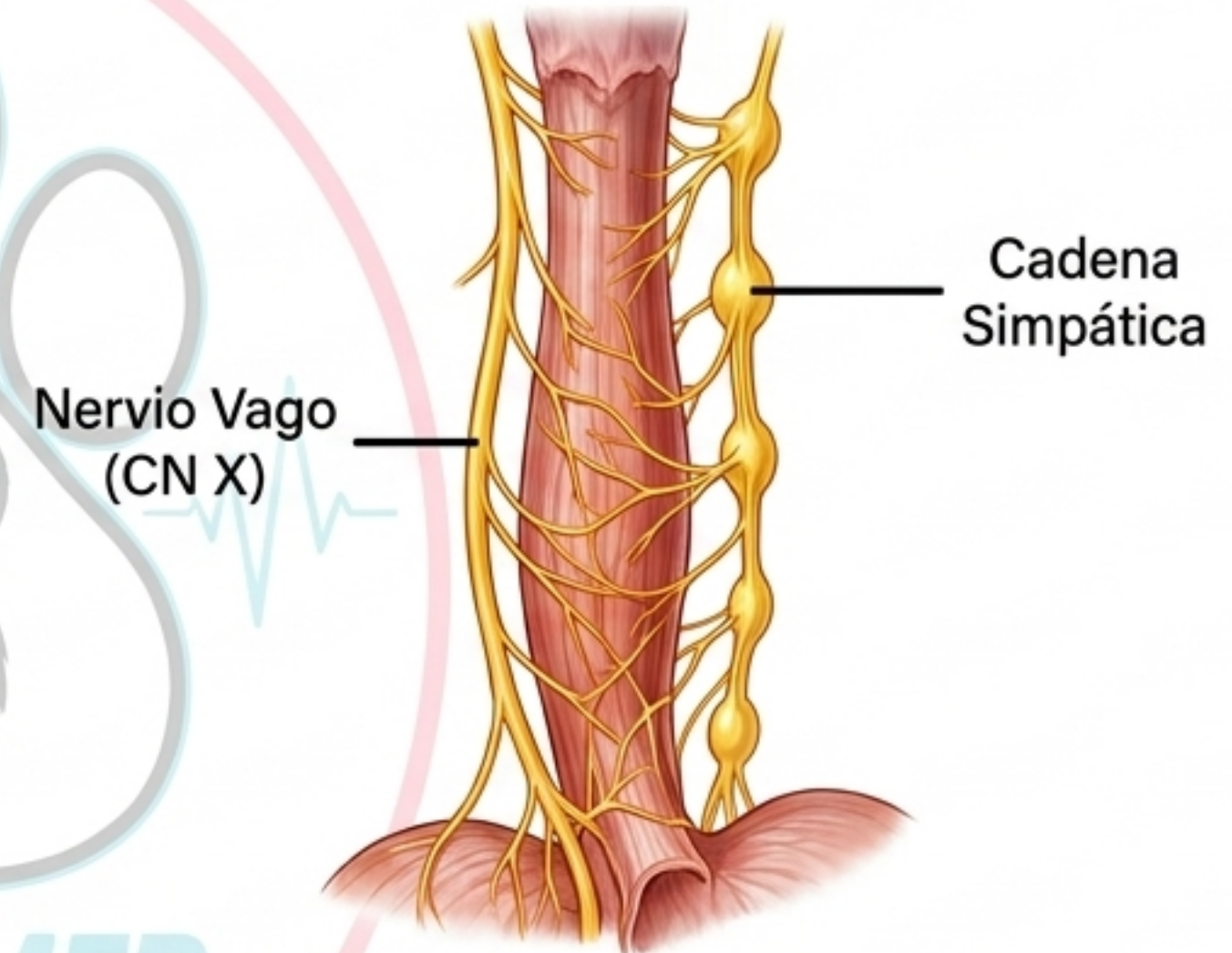
Convexidad Izquierda: A nivel cervical, abordaje quirúrgico preferido por el lado izquierdo del cuello.

Vascularización e Inervación Esofágica

Vascularización



Inervación



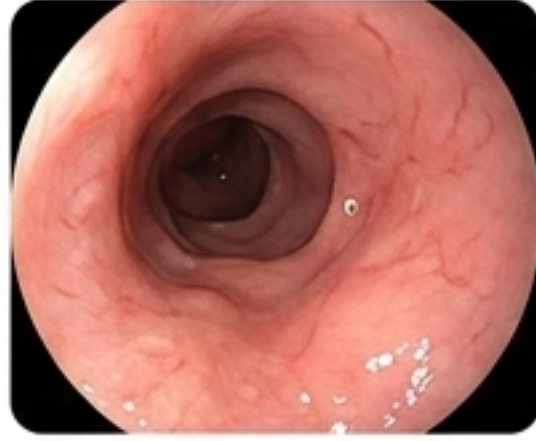
Implicación Vascular

- **Várices Esofágicas:** Anastomosis portosistémica.
- La hipertensión portal dilata venas periesofágicas y submucosas.
- Riesgo de hemorragia digestiva alta.

Implicación Nerviosa

- **Peristaltismo:** Control neurovegetativo (Nervio Vago).
- Coordina ondas primarias y secundarias para el aclaramiento esofágico.

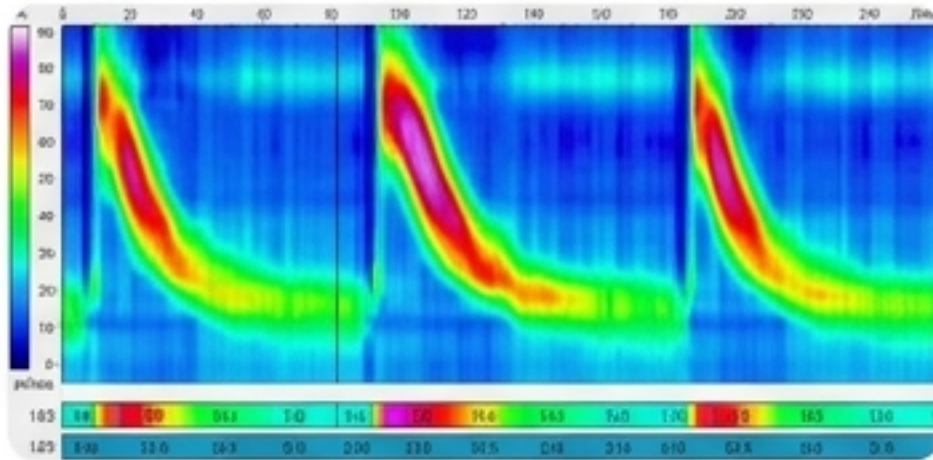
Arsenal Diagnóstico Especializado



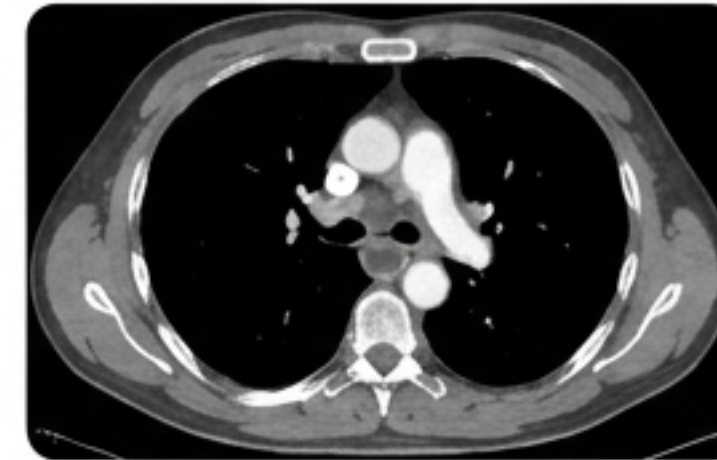
Endoscopía: Visualización directa y biopsia. Gold standard para diferenciar patología benigna de maligna (metaplasia/cáncer).



Esofagograma: Radiografía contrastada. Define anatomía, estenosis, megaesófago (Acalasia) y fístulas.

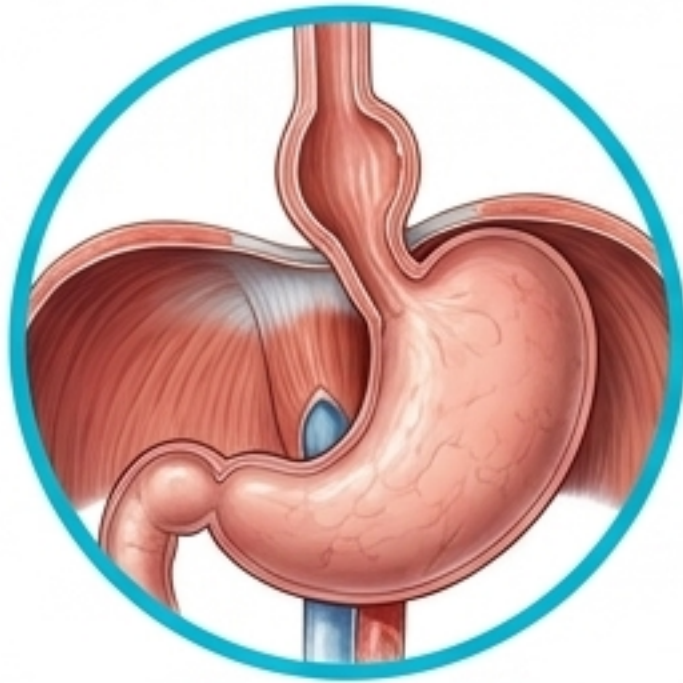


Manometría: Mide presiones de esfínteres (EEI/EES) y peristaltismo. Clave en Acalasia y hernias hiatales.



TAC / RMN: Estadiaje tumoral (TNM). Evalúa invasión a estructuras adyacentes (tráquea, aorta).

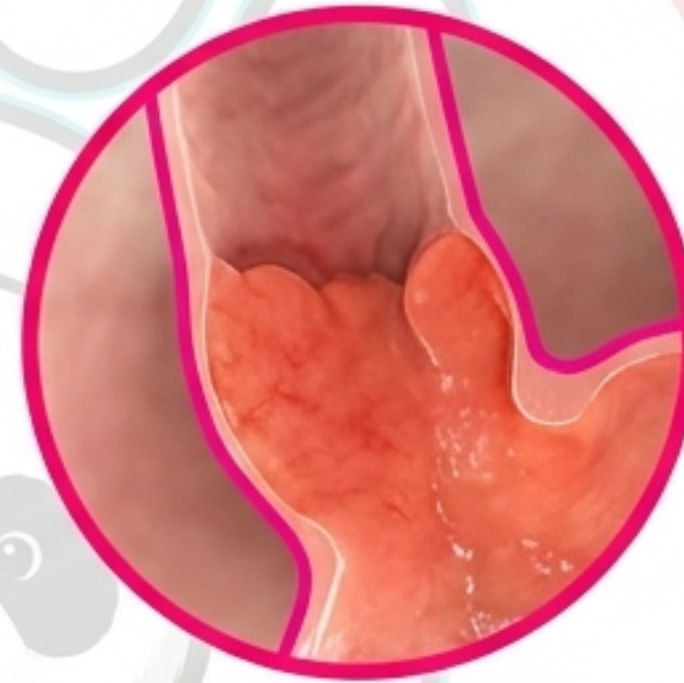
Reflujo, Hernias Hiatales y Esófago de Barrett



Hernia Hiatal



ERGE
(Reflujo Gastroesofágico)



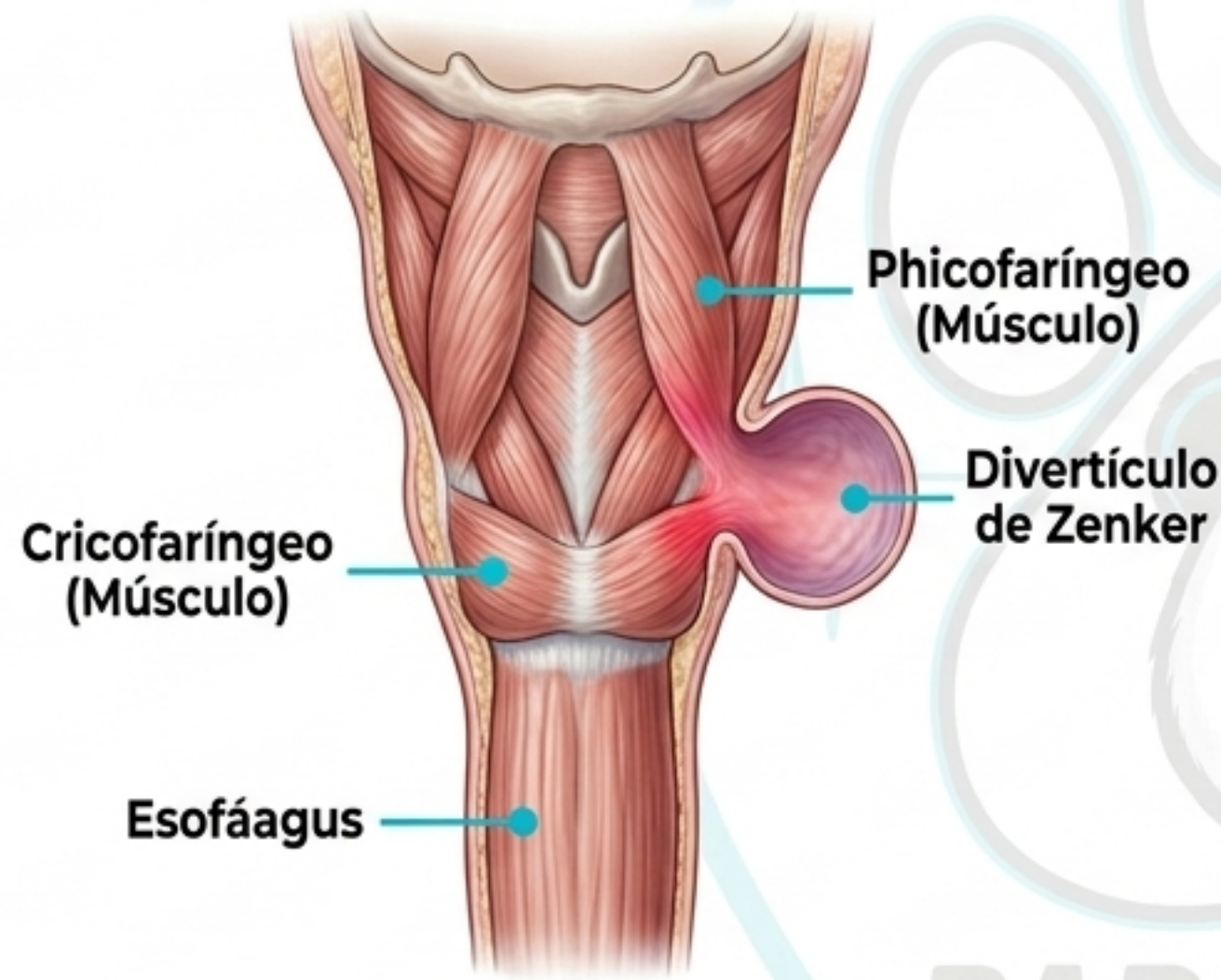
Esófago de Barrett



Adenocarcinoma

- **Falla Mecánica:** Debilidad de los pilares diafragmáticos y del EEI.
- **Metaplasia** -> Displasia (Bajo/Alto grado) -> Cáncer.
- **Indicación Quirúrgica:** Funduplicatura laparoscópica/abierta para restaurar la barrera antirreflujo y prevenir malignidad.

Divertículo de Zenker: Fisiopatología y Cirugía



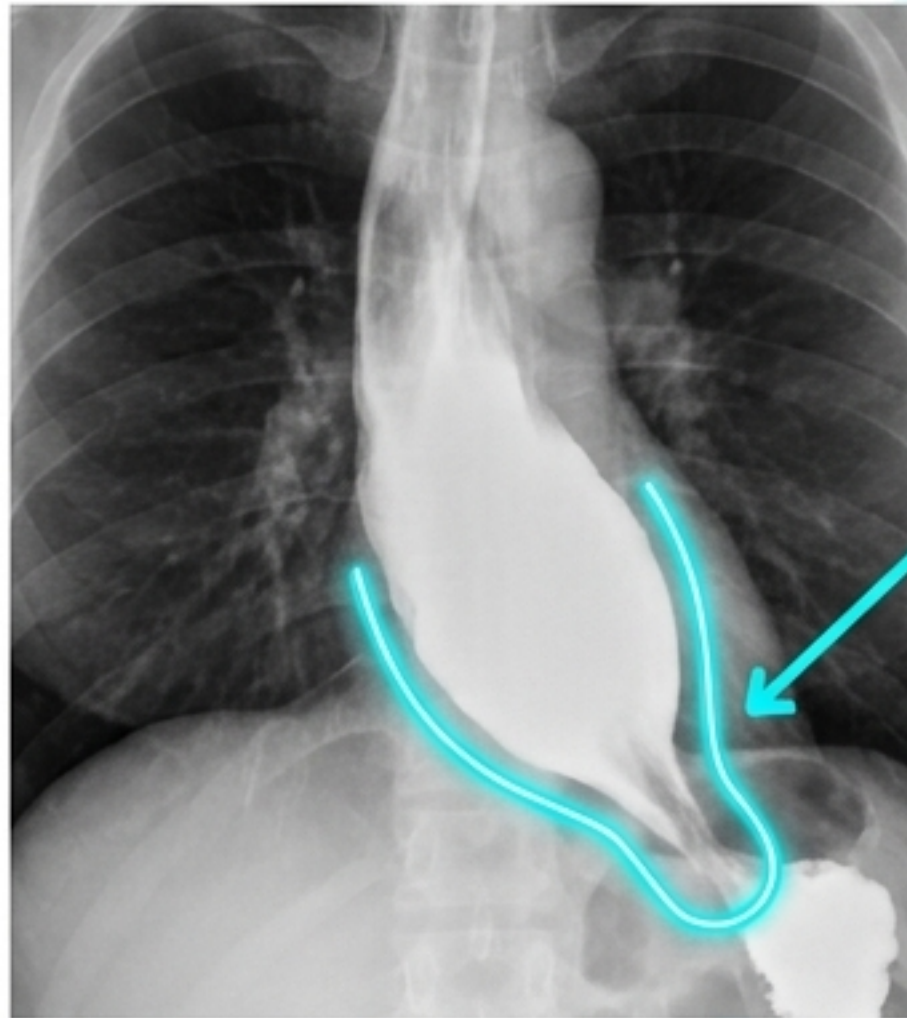
Fisiopatología: Divertículo por pulsión (falso: solo mucosa/submucosa). Debilidad faringoesofágica.

Posicionamiento: Hiperextensión cervical

- (almohada interescapular). Abordaje cervical izquierdo (aprovecha la convexidad esofágica).

Paso Quirúrgico Crítico: Identificación, resección y obligatoria **Miotomía del Cricofaríngeo** para prevenir recidivas. **Cierre transversal.**

Acalasia: Falla de Relajación del EEI



Pico de pájaro
(Bird's beak)

- Clasificación: Primaria (Idiopática - aganglioneosis) vs. Secundaria
- (Enfermedad de Chagas / *Chagas* / *Trypanosoma cruzi* o pseudoacalasia tumoral).

Grado de Acalasia (Diámetro Esofágico)

**Grado 1: < 4 cm diámetro
(Tratamiento médico inicial).**

Grado 2: 4 - 7 cm diámetro.

Grado 3: 7 - 10 cm diámetro.

**Grado 4: > 10 cm diámetro
(Megaesófago masivo / Eje
sigmoideo).**

Tratamiento Quirúrgico de la Acalasia

Diagnóstico de Acalasia

Grados 1-3

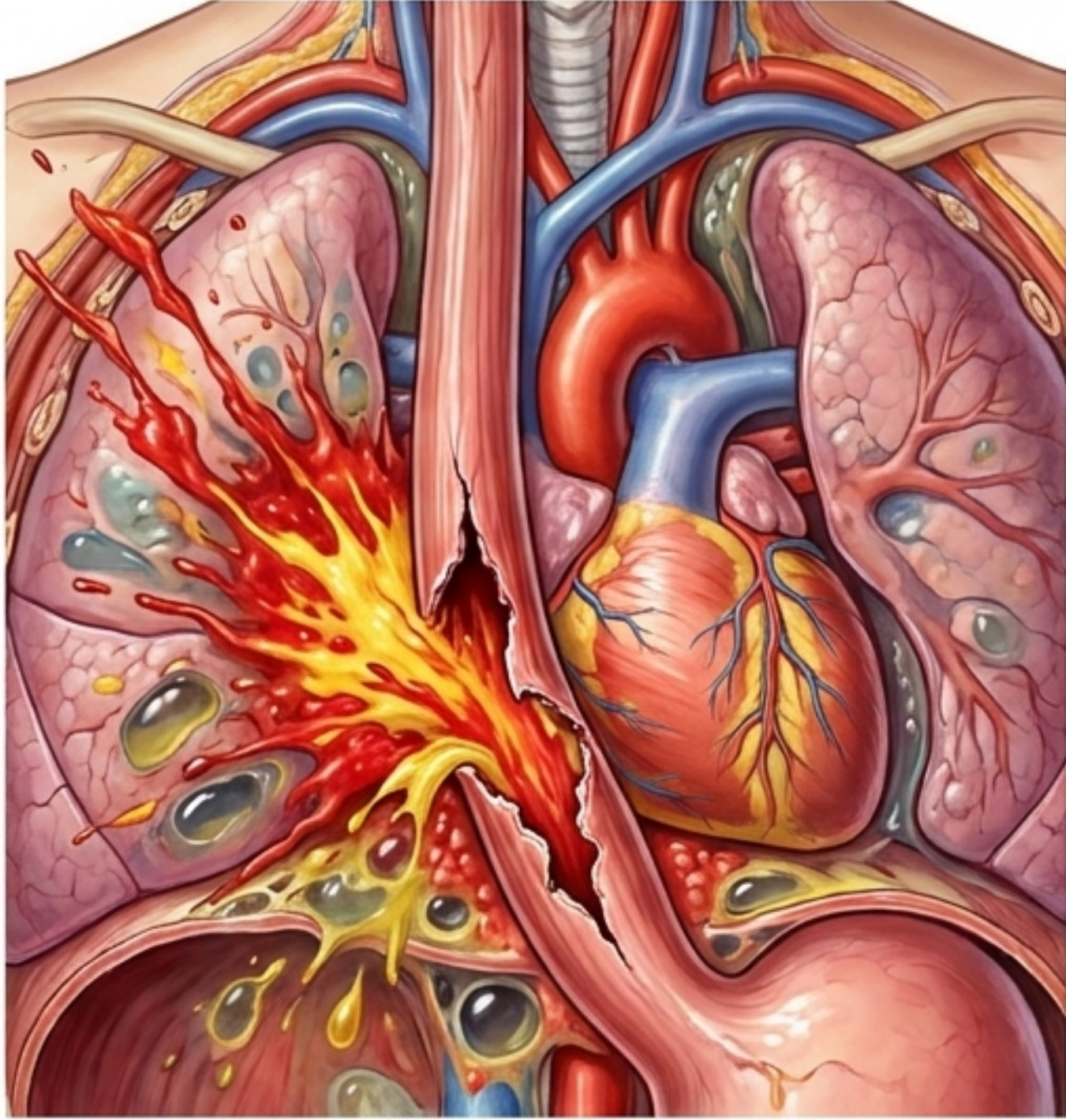
Grado 4

Cardiomiectomía de Heller + Funduplicatura

Esofagectomía Transhiatal

- **Miotomía de Heller:** Sección de fibras musculares dejando intacta la mucosa. Permeabiliza el EEI.
- **Funduplicatura:** Procedimiento antirreflujo complementario obligatorio (parcial/collar) para evitar ERGE severo post-miotomía.
- **Grado 4:** Resección total debido al riesgo de carcinoma (tras 25-35 años) y estasis severa.

Perforaciones Esofágicas y Síndrome de Boerhaave



Emergency Protocol Matrix

- **Etiología:** Traumática (armas, endoscopías, cuerpos extraños) vs. Síndrome de Boerhaave (Perforación espontánea por vómito explosivo).
- **Clínica Crítica:** Dolor torácico lacerante, enfisema subcutáneo, shock séptico rápido.

Manejo Quirúrgico (Tiempo Dependiente)

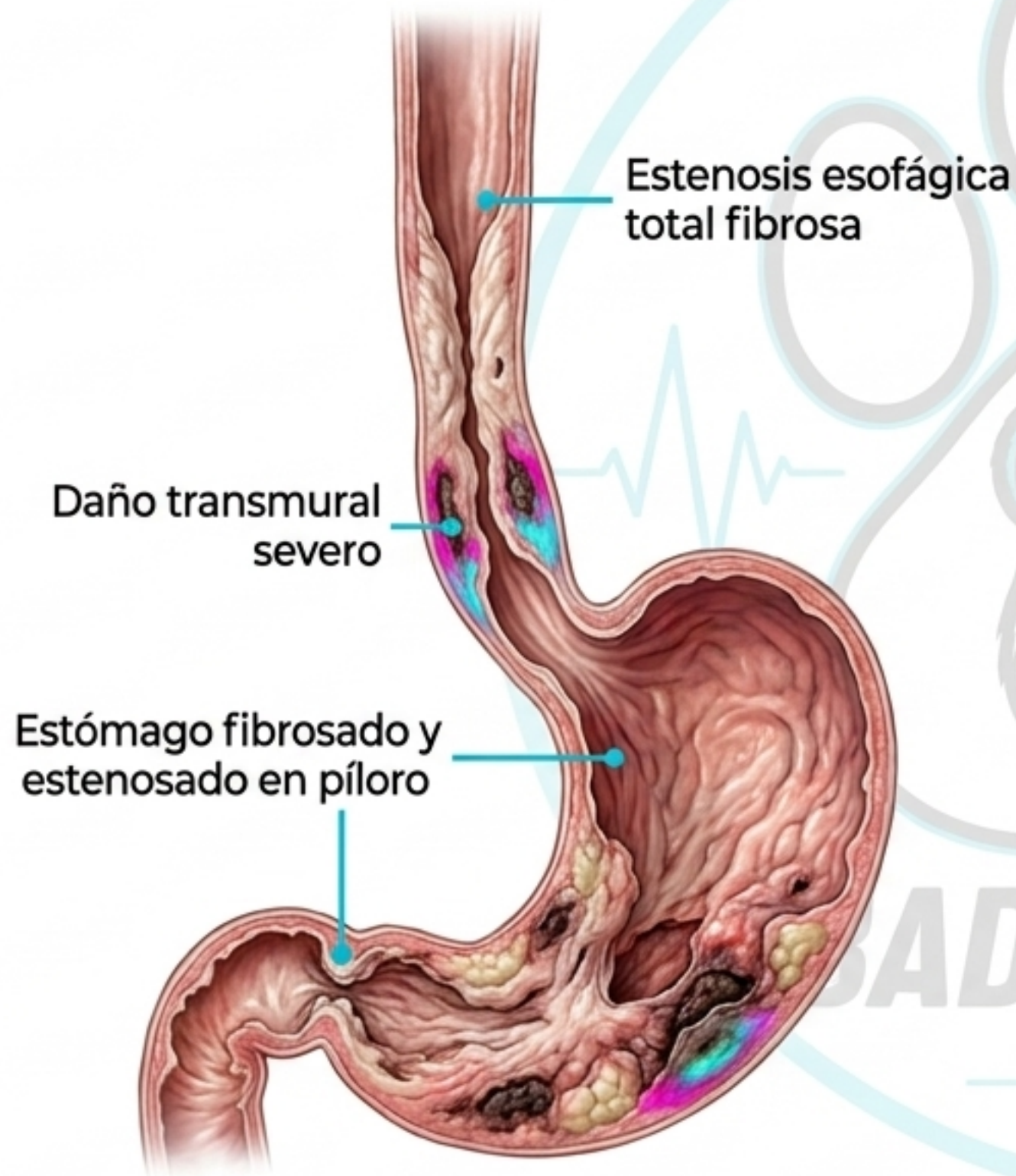
< 24h: Cierre primario + drenaje.

> 24h o Sepsis: Esofagostomía cervical (exclusión), gastrostomía de alimentación y drenaje torácico amplio para evitar mediastinitis fatal.

Ingestión de Cáusticos (Ácido Muriático)

Staged Management

- Step 1** **Fase Aguda:** Daño transmural y necrosis. Estenosis fibrosa total. No pasar sonda nasogástrica a ciegas.
- Monitoreo intensivo
 - Evaluación de extensión del daño
 - Prevención de perforación
- Step 2** **Soporte Nutricional:** Gastrostomía o Yeyunostomía de urgencia para alimentación (el estómago a menudo también está destruido/estenosado en píloro).
- Alimentación enteral temprana
 - Mantener estado nutricional óptimo
 - Acceso enteral distal seguro
- Step 3** **Fase Reconstructiva:** Al ser inutilizable el esófago y frecuentemente el estómago, la reconstrucción definitiva requiere Transposición Colónica.
- Técnica quirúrgica compleja
 - Restauración de continuidad digestiva
 - Consideraciones funcionales a largo plazo



Masterclass Quirúrgica: Transposición Colónica



Vascular Preservation

- **Arco de Riolo:** La clave de la viabilidad del injerto.
- Conecta la arteria mesentérica superior (vía cólica media/derecha) con la arteria mesentérica inferior (vía cólica izquierda).
- **Regla de Oro:** El segmento de colon transpuesto sobrevive exclusivamente gracias a la arteria cólica izquierda ascendente latiendo hasta el cuello. Una disección meticulosa es vital.

Ascenso y Anastomosis del Injerto Colónico

Ruta

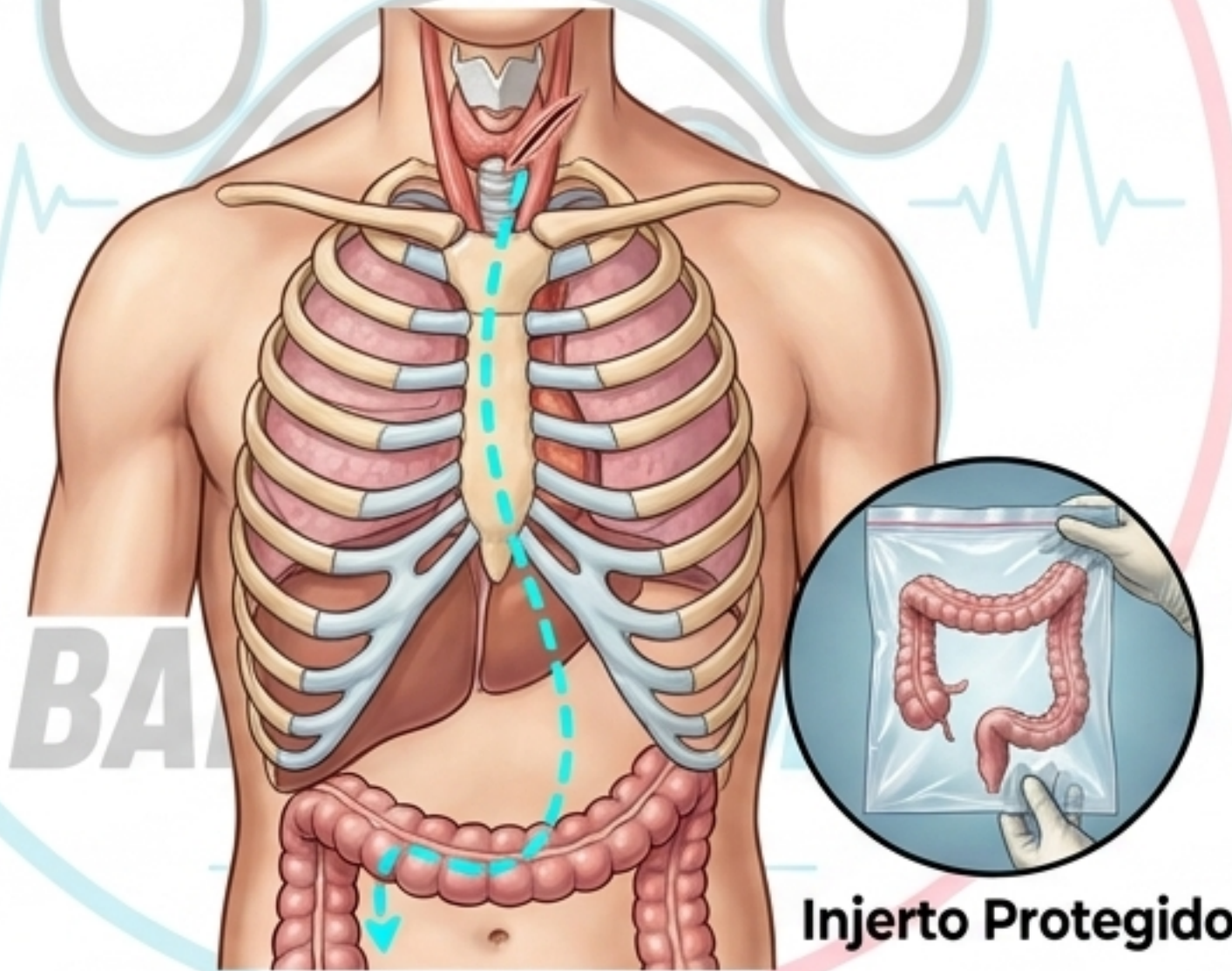
- Ascenso a través del mediastino anterior (retroesternal).

Preparación

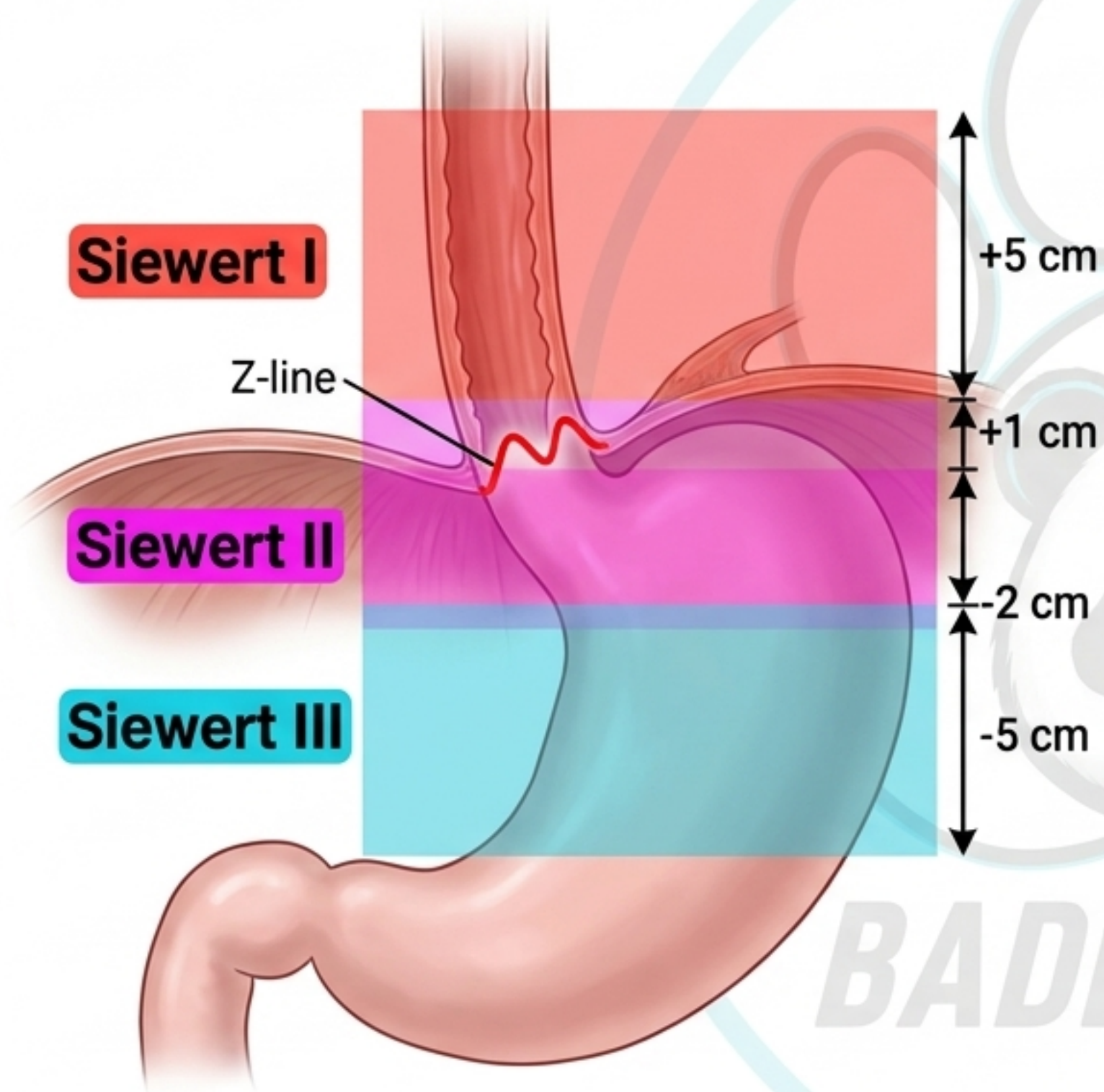
- Apendicectomía profiláctica obligatoria (evita apendicitis intratorácica postoperatoria).
- Limpieza y medición exacta del injerto.

Anastomosis

- Faringo-colo-anastomosis cervical término-terminal.
- Colo-gastro/yeyuno anastomosis abdominal.



Cáncer de Esófago y Cardias (Clasificación Siewert)



Clasificación de Siewert-Stein para Adenocarcinoma

Tipo I (Supracardial)

Esofagectomía + ascenso gástrico.

Tipo II (Cardial Verdadero)

Esofagectomía distal + Gastrectomía total radical con anastomosis esófago-yeyuno (Y de Roux).

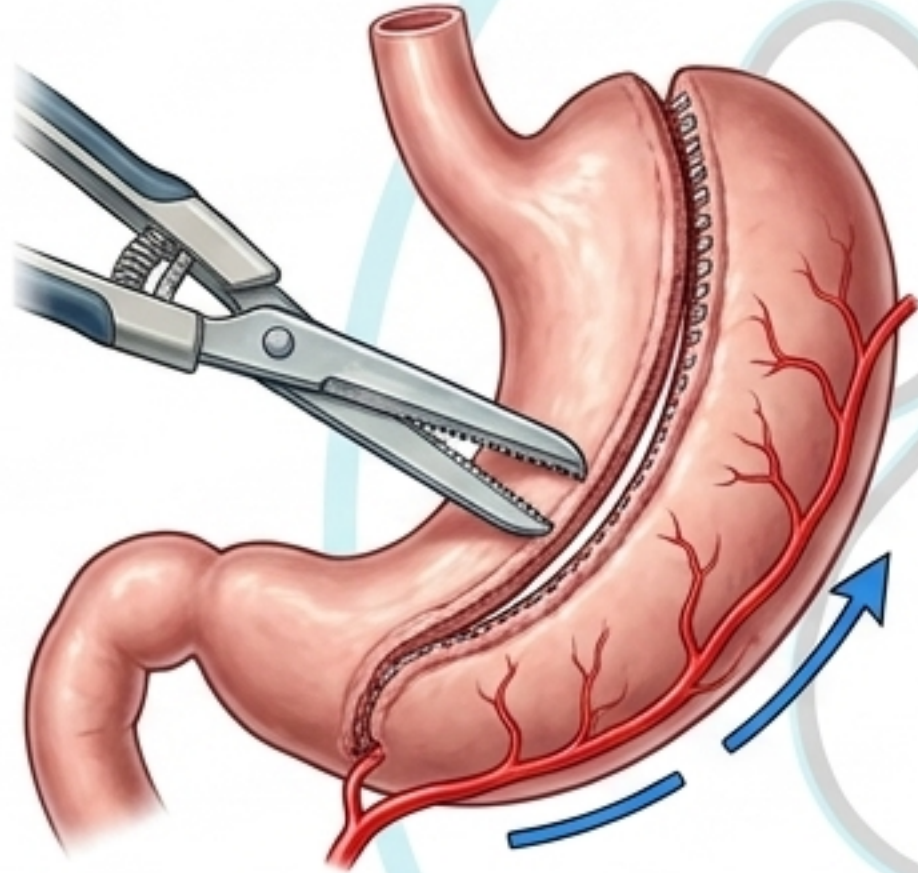
Tipo III (Subcardial)

Manejo similar al cáncer gástrico (Gastrectomía total).

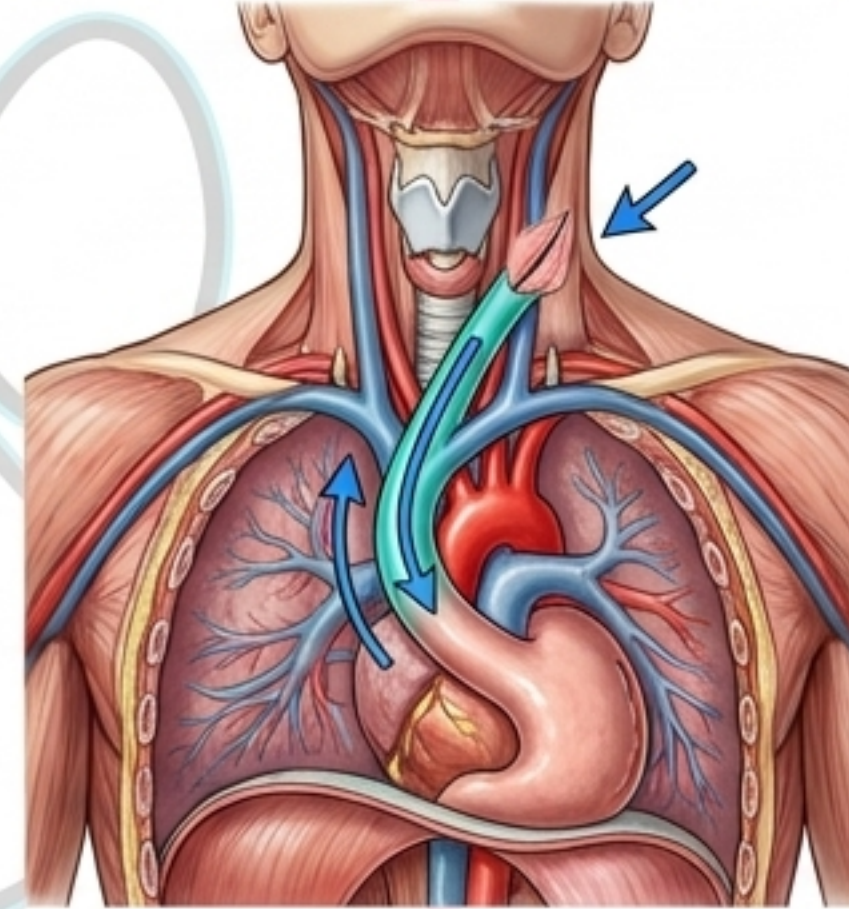
Nota Crítica: El estadiaje TNM intraoperatorio define resecabilidad vs. derivación paliativa.

Esofagectomía y Reconstrucción Gástrica

Tubo Gástrico



Ruta de Ascenso



Posicionamiento

Paciente en decúbito supino, cabeza hiperextendida, abordaje cervical izquierdo y supraumbilical simultáneo.

Tubo Gástrico

Tubulización de la curvatura mayor del estómago conservando su irrigación.

Ruta

Ascenso por el mediastino posterior (lecho original del esófago) para la anastomosis esófago-gástrica cervical.



SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES PARA MÁS CONTENIDO MÉDICO:



Facebook



Instagram



YouTube



RuTube



OnlyFans



Telegram



TikTok

Proyecto Oficial BADBEAR.MED - Dominio Clínico y Quirúrgico